

# 中山醫學大學附設醫院

| 主題名稱   | 焦慮病人照護作業標準<br>Operating Standards for Patients with Anxious Symptoms |     |         |      |                 |
|--------|----------------------------------------------------------------------|-----|---------|------|-----------------|
| 編號     | A31000-Q02-W-A34                                                     | 制定者 | PSY 羅秋蘭 | 公布日期 | 104 年 06 月 12 日 |
| 制定單位   | 護理部                                                                  | 核准者 | 吳姿蓉     | 修正日期 | 113 年 04 月 16 日 |
| 版本/總頁數 | 第 1.3 版/9 頁                                                          | 審查者 | 劉俞均     | 檢閱日期 | 114 年 04 月 10 日 |

## 一、目的

提供護理人員對於住院病人焦慮評估與處置之照護作業標準。

## 二、範圍

護理部各單位（急診及小兒科病童未滿 15 歲除外）（含中興分院）。

## 三、說明

### （一）焦慮定義

1. 是一種主觀的憂慮及壓力感，其導因可以是實際的或主觀感受到的威脅，產生不確定、不安全感，會伴有生理上的變化或不自主的行為，該行為的目的是要消除緊張感。焦慮會影響人格，改變一個人對自尊、自我價值感的評價，會使病人因應及學習的能力降低，並使生活品質、疾病之免疫力與對治療之反應變差及增加疼痛。
2. 焦慮分為特質性焦慮及情境性焦慮兩種，特質性焦慮強調焦慮是一種人格特質，每個人所表現的型態是不同的；情境性焦慮則重視特定情境所引發的焦慮。環境的改變會造成情境性焦慮的改變，但特質性焦慮則較少受到環境改變的影響。適度的焦慮有時可協助個體解除困境，完成個人目標；若焦慮持續存在無法排除，或是屢次無故的極度焦慮，則視為不正常的焦慮，可定義為焦慮障礙疾病。
3. 焦慮是一種主觀感受，因此每個人對其目前焦慮狀態的認知及自評分數定義不盡相同，臨床評估時亦可能出現不焦慮/低分數、低焦慮/高分數等狀況，護理人員此時可與病人討論對此分數的定義或想法，以釐清對自評分數的高度誤差。

|      |                  |      |         |        |     |
|------|------------------|------|---------|--------|-----|
| 主題名稱 | 焦慮病人照護作業標準       | 制定單位 | 護理部     |        |     |
| 編號   | A31000-Q02-W-A34 | 版本   | 第 1.3 版 | 頁碼/總頁數 | 2/9 |

## (二) 焦慮評估方式

- 1.病人入院由「HIS/住院護理系統/護理評估/心理社會靈性」進行情緒狀態評估，若勾選「焦慮」須以數字評估量表(numerical rating scale, NRS)測量焦慮程度並記錄，自評分數 $\geq 1$ 分，且符合焦慮護理問題定義性特徵（客觀資料）2項，須書寫焦慮感受護理問題，執行護理措施與提供衛教指導且每日以NRS評值焦慮是否緩解。若情緒狀態評估無焦慮，則不須以NRS測量。

查詢患者 護理查核 護理執行 生理監測 護理評估 護理計劃 護理紀錄 醫囑查詢 報告查詢 行政作業 說明(H) 關閉(C)

患者：99999999 測試患者 男 1954/05/10(69 歲又 11 個月) 168cm/70kg 床號：3T37-2 入院時間：2022/10/31 08:57 內科

暫存 完成 匯入前次評估紀錄 電子

※評估人員 P918 ※評估時間 2023/09/15 08:04 評估單狀態：完成

基本資料 | 聯絡資料 | 病史 | 外觀 | 皮膚 | 心肺 | 泌尿生殖 | 胃腸營養 | 肌肉骨骼 | 神經疼痛 | 心理社會靈性 | 環境介紹

※情緒狀態 ☐ 無法評估 ☒ 可評估 ☐ 平靜 ☐ 淡漠 ☐ 高昂 ☒ 焦慮 ☐ 憂鬱 ☐ 憤怒 ☐ 失落 其他

※當有壓力時的反應 ☒ 無法評估 ☐ 可評估 ☐ 解決問題 ☐ 服藥 ☐ 尋求協助 ☐ 不理會 其他

※支持系統 ☒ 無法評估 ☐ 無 ☐ 有 ☐ 同住的家人 ☐ 非同住的家人 ☐ 社會團體 ☐ 鄰居 ☐ 朋友 其他

新增護理問題作業

護理問題 焦慮感受 日期時間 2024/04/15 10:10

患者主訴  
擔心自己生病住院要花很多醫藥費。

客觀資料

☒ 自述焦慮、擔憂、緊張 ☐ 心跳加快  
☐ 血壓上升 ☐ 呼吸速率增加  
☐ 掌心出汗增加 ☐ 肌肉張力增加  
☐ 手部顫抖 ☐ 說話速度加快、音量增加  
☐ 聲音發抖 ☐ 胃口改變  
☐ 尿急 ☐ 頻尿  
☐ 感覺範圍變窄、關注自己、旁若無人 ☐ 不適當的行為害怕  
☐ 高度警覺性 ☐ 否認  
☐ 思考中斷 ☐ 注意力不集中

增加下一個客觀資料

尋因/危險因子/相關因素

☐ 對身體健康之威脅 ☐ 不確定  
☐ 對事件缺乏控制感

其他尋因/危險因子/相關因素

護理目標/護理措施

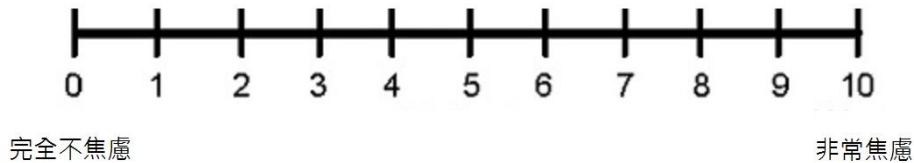
☐ 能說出導致焦慮的原因及因應方法  
☐ 能說出焦慮感減輕或出現明顯之放鬆徵象  
☐ 能運用適當的調適機轉以減輕焦慮  
☐ 其它：

增加下一個目標

確定(O) 取消(C)

|      |                  |      |         |        |     |
|------|------------------|------|---------|--------|-----|
| 主題名稱 | 焦慮病人照護作業標準       | 制定單位 |         | 護理部    |     |
| 編號   | A31000-Q02-W-A34 | 版本   | 第 1.3 版 | 頁碼/總頁數 | 3/9 |

2.NRS是由病人自評焦慮分數（0-10分，0分為完全不焦慮，10分為非常焦慮），每日評估至0分且焦慮緩解即可結束護理問題。



- 3.若其他護理問題於「定義性特徵關鍵字」出現焦慮，以因果邏輯概念思考，仍以主要護理問題照護即可，不須另外下立焦慮感受護理問題，舉例說明：病人因心肌收縮力改變（導因）導致「心輸出量減少」（護理問題），客觀資料呈現焦慮，此時仍以主要護理問題「心輸出量減少」照護，但仍須以NRS每日評值焦慮緩解狀況。
- 4.緩和醫療病房以身心靈照護評估，撰寫安寧心理社會評估之情緒問題或安寧靈性評估之紀錄，若有焦慮情形於此處呈現。

### （三）護理計劃

1.長期護理目標：能適當的調整其焦慮。

短期護理目標：

- (1)能描述其立即性的窘迫獲得緩解。
- (2)能說出他是被護理人員所了解的。
- (3)能確認其焦慮的來源。
- (4)能指出相關的因應技巧。
- (5)能運用新的、有效的因應策略。
- (6)病人能將從治療性情境所學習到的運用至生活情境中。
- (7)家屬能改變過去支持病人失調行為的不適當行為模式。

2.護理措施：

(1)能描述其立即性的窘迫獲得緩解，護理措施有：

- A. 陪伴病人，接受病人的焦慮。
- B. 說話速度放慢、平穩，使用短而簡明的句子。

|      |                  |      |         |        |     |
|------|------------------|------|---------|--------|-----|
| 主題名稱 | 焦慮病人照護作業標準       | 制定單位 |         | 護理部    |     |
| 編號   | A31000-Q02-W-A34 | 版本   | 第 1.3 版 | 頁碼/總頁數 | 4/9 |

C. 向病人保證護理人員會隨時協助他自我控制。

D. 給予簡短指引以協助病人做決定；若病人能自行做決定，護理人員宜支持其決定。

E. 降低過多的刺激，提供安全的環境，並避免不愉快事件的發生。

F. 陪伴病人散步，以消耗因焦慮所積存的能量，或安排可轉移其注意力的活動，設法減輕其焦慮感。

G. 對急性焦慮期中的病人須密切監測，保護其安全，避免病人自傷或失控。

(2)能說出他是被護理人員所了解的，護理措施有：

A. 傾聽以傳達信任感，並藉此收集資料，瞭解病人的防衛機轉。

B. 運用同理心傳遞關懷。

C. 集中焦點於現存不舒服的事實，而不需強調病人自我功能失調的部份，如：儀式化行為。

D. 鼓勵病人描述其感覺及行為目的。

E. 協助病人接受其焦慮，克服否認或阻抗之防衛機轉。

F. 教導焦慮的徵象或症狀，以促進病人正確的知覺或減輕多的焦慮，並培養其自我控制的能力。

(3)能確認其焦慮的來源，護理措施有：

A. 鼓勵病人討論過去相關的事件，以確認其壓力源。

B. 指出病人其行為與感覺間的關聯性，以協助自我了解，如詢問：我注意到你。

C. 教導認知治療中的觀念，如：焦慮是因對情境有錯誤評估的結果；焦慮是個人主觀思考的結果，以做為行為改變的基礎。

D. 提出問題，藉以澄清或促進邏輯性思考，而能有正確的認知，如詢問：你有什麼證據？你的結論是依據事實或感覺而來？你認為會發生什麼最壞的事？

E. 引導病人以不同角度對事件做不同的解釋。

|      |                  |      |         |        |     |
|------|------------------|------|---------|--------|-----|
| 主題名稱 | 焦慮病人照護作業標準       | 制定單位 |         | 護理部    |     |
| 編號   | A31000-Q02-W-A34 | 版本   | 第 1.3 版 | 頁碼/總頁數 | 5/9 |

(4)能指出相關的因應技巧，護理措施有：

- A. 能確認過去曾使用過的緩解方式。
- B. 當病人使用較健康的因應技巧時，給予正增強。
- C. 請病人對自己做評估。
- D. 促進病人對自己的缺點能有合乎現實的評估。

(5)能運用新的、有效的因應策略，護理措施有：

- A. 能接受病人的感覺，尤其憤怒、害怕、罪惡或羞恥。
- B. 教導並協助病人運用放鬆技巧。
- C. 利用洗溫水澡、喝溫牛奶或陪伴病人等方式以協助病人的睡眠。
- D. 與病人一起訂出每天活動的作息表，尤其是安排過去病人喜歡從事的活動。
- E. 協助病人使用正向的自我對話，如：我能處理這件事；我會做得很好。
- F. 當病人學習到新的因應方法時，給予支持。
- G. 對病人的能力或成就給予肯定。

(6)病人能將從治療性情境所學習到的運用至生活情境中，護理措施有：

- A. 給予機會讓病人執行正常的角色行為。
- B. 對預期會出現的壓力情境，提供病人做行為的模擬預演。
- C. 與病人討論其所運用的成功因應技巧，並指導應用此成功因應技巧於生活情境中。

(7)家屬能改變過去支持病人失調行為的不適當行為模式，護理措施有：

- A. 教導家屬，當病人出現較健康的行為時，給予正增強。
- B. 教導家屬，不要為病人承擔其所應負責的角色工作。
- C. 教導家屬，要去關懷病人本身，而不是過度關注病人的症狀。

(8)當焦慮持續無法緩解，建議會診身心科醫師執行進一步評估與治療。

2.預期成果：

|      |                  |      |         |        |     |
|------|------------------|------|---------|--------|-----|
| 主題名稱 | 焦慮病人照護作業標準       | 制定單位 |         | 護理部    |     |
| 編號   | A31000-Q02-W-A34 | 版本   | 第 1.3 版 | 頁碼/總頁數 | 6/9 |

(1)在護理措施執行後，病人自述焦慮情形減輕：出現明顯之放鬆現象，生理警覺狀態減少，能專注及處理外界資訊，對刺激的行為反應適當。

(2)病人在接受壓力性之醫療過程中皆不會出現嚴重焦慮或恐慌。

(3)病人能以輕鬆而不緊張的態度參與治療，且口述在過程中感覺滿意，適當時間會出現健康尋求行為。

#### (四) 實施及修訂

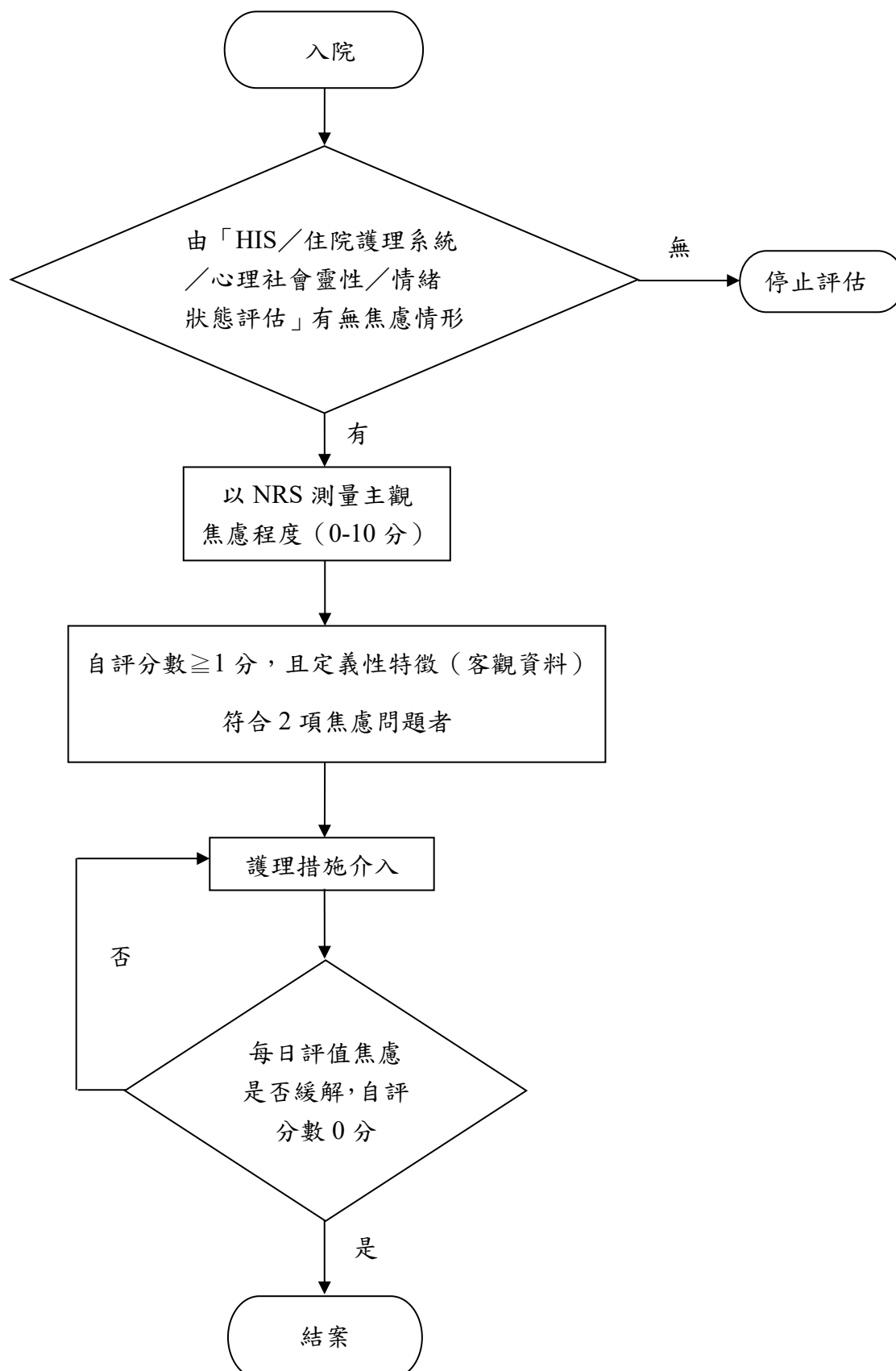
本辦法經護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施，修正時亦同。

## 四、使用表單

(略)

|      |                  |      |         |        |     |
|------|------------------|------|---------|--------|-----|
| 主題名稱 | 焦慮病人照護作業標準       | 制定單位 |         | 護理部    |     |
| 編號   | A31000-Q02-W-A34 | 版本   | 第 1.3 版 | 頁碼/總頁數 | 7/9 |

## 五、流程圖



|      |                  |      |         |        |     |
|------|------------------|------|---------|--------|-----|
| 主題名稱 | 焦慮病人照護作業標準       | 制定單位 |         | 護理部    |     |
| 編號   | A31000-Q02-W-A34 | 版本   | 第 1.3 版 | 頁碼/總頁數 | 8/9 |

## 六、參考資料

- (一) 王蔚芸、王桂芸、湯玉英(2007)．焦慮之概念分析，長庚護理，18(1)，59-66。
- (二) 巫慧芳(2012)．焦慮障礙病人之護理．於蕭淑貞總校閱，精神科護理概論（八版，409-428 頁）．台北市：華杏。
- (三) 周幸生、程仁慧合譯(2006)．自我感受—自我概念型態：焦慮，新臨床護理診斷（二版，553-569 頁）．台北市：華杏。
- (四) 葉雅惠、江慧玲、林麗英、許鳳珠(2010)．多媒體光碟於脊椎手術病患術前焦慮之成效，護理暨健康照護研究，6(4)，299-307。
- (五) 呂雀芬、陳妙絹、許世杰(2012)．An overview of generalized anxiety disorder and reflections on the effective nursing care of patients with this disorder，精神衛生護理雜誌，7(1)，1-10。

## 七、附件

(略)



|      |                  |      |         |        |     |
|------|------------------|------|---------|--------|-----|
| 主題名稱 | 焦慮病人照護作業標準       | 制定單位 |         | 護理部    |     |
| 編號   | A31000-Q02-W-A34 | 版本   | 第 1.3 版 | 頁碼/總頁數 | 9/9 |

## 八、文件修正紀錄

| 修正日期      | 版本  | 修正說明                                                                          | 備註                                                                                   |
|-----------|-----|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 104.06.12 | 1.0 | 新制定                                                                           | 104 年 06 月 12 日<br>護理部照護標準委員會通過；104 年 06 月 12 日公布                                    |
| 105.02.02 | 1.1 | 1. 第二項適用範圍排除急診及未滿 15 歲小兒科病童。<br>2. 第三項第(二)目焦慮評估方式修正。<br>3. 第五項流程圖與作業標準內容同步修改。 | 105 年 02 月 02 日<br>護理部照護標準委員會通過                                                      |
| 106.04.10 | 1.1 | 年度檢閱，無修改。版本不變動。                                                               |                                                                                      |
| 107.04.02 | 1.1 | 年度檢閱，無修改。版本不變動。                                                               |                                                                                      |
| 108.04.11 | 1.2 | 1. 第二項新增（含中興分院）。<br>2. 第三項第四日本辦法經委員會通過後公布實施，改為護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施。          | 108 年 04 月 11 日<br>照護標準組會議通過；108 年 05 月 15 日<br>護理長會議通過；108 年 05 月 20 日<br>督導會議通過公布。 |
| 109.04.09 | 1.2 | 年度檢閱，無修改。版本不變動。                                                               |                                                                                      |
| 110.04.01 | 1.2 | 年度檢閱，無修正。版本不變動。                                                               |                                                                                      |
| 111.04.07 | 1.2 | 年度檢閱，無修正。版本不變動。                                                               |                                                                                      |
| 113.04.16 | 1.3 | 1. 第三項第二目之 1.3.說明內容修訂。<br>2. 第三項第二目焦慮評估方式新增 4.說明內容。                           | 113 年 04 月 11 日<br>照護標準組會議通過； 113 年 04 月 16 日<br>督導會議通過公布。                           |
| 114.04.10 | 1.3 | 年度檢閱，無修正。版本不變動。                                                               |                                                                                      |
|           |     |                                                                               |                                                                                      |